DR. JOSEHP CHRISTOPHER CASTILLO CUENCA
MÉDICO ANATOMOPATÓLOGO | C.M.P. 56435 R.N.E. 029091
Email: grupopatologia2012@gmail.com | Cel: 986396733

APELLIDOS Y NOMBRES : BERNABE, ELENA		**26Q-224**
EDAD : 37 AÑOS	**SEXO :** FEMENINO	
FECHA DE RECEPCIÓN : 03/08/2026	**FECHA DE INFORME :** 07/08/2026	
INDICACIÓN: DR. JORGE ALBERTO MUÑANTE ARZAPALO		

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:

Se recibe vesícula biliar de configuración elongada, que mide 7.5 x 4.0 x 3.5 cm, con superficie serosa de aspecto. granular y congestiva, presentando áreas de fibrinopurulencia adheridas. Al corte transversal, la pared muestra un. marcado engrosamiento difuso (hasta 1.2 cm de espesor), con consistencia firme y aspecto blanquecino grisáceo,.

sugerente de fibrosis transmural. La luz se encuentra distendida y contiene material biliar turbio, espeso y de coloración. verdoso oscura. La mucosa presenta pérdida de su patrón reticular habitual, con áreas de ulceración focal y depósitos. de material calcáreo granular adheridos a la pared.

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA:

Los cortes histológicos revelan una pared vesicular con arquitectura distorsionada por un denso infiltrado inflamatorio. crónico, predominante linfoplasmocitario y con agregados linfoides foliculares, que se extiende desde la submucosa. hasta la capa muscular y serosa. Este proceso se superpone con un componente agudo exudativo, caracterizado por.

abundante infiltrado neutrofílico intraparietal, microabscesos en la mucosa y ulceración del epitelio superficial con. exudado fibrinopurulento en la luz. Se observa fibrosis hialina extensa que disocia las fibras musculares lisas, así como.

numerosos senos de rokitansky aschoff dilatados, algunos de ellos rellenos de barro biliar e infiltrados por histiocitos. espumosos. El epitelio de revestimiento remanente muestra metaplasia escamosa focal y cambios regenerativos. atípicos reactivos, sin evidencia de displasia franca ni invasión estromal. No se identifican cc neoplásicas ni.

depósitos amiloides.

DIAGNÓSTICO HISTOLÓGICO:

VESICULA BILIAR. VESÍCULA BILIAR CON COLECISTITIS CRÓNICA REAGUDIZADA, CON EXTENSA FIBROSIS. MURAL, ULCERACIÓN MUCOSA Y ABSCESOS INTRAMURALES, SIN EVIDENCIA DE. NEOPLASIA INTRAEPITELIAL NI CARCINOMA INFILTRANTE.

VALIDACIÓN DIGITAL
Escanee para certificar la autenticidad clínica de este informe.
DOC: 26Q-224

Josehp C. Castillo
JOSEHP C. CASTILLO CUENCA
MÉDICO ANATOMO PATÓLOGO
C.M.P. 56435 R.N.E. 029091

JOSEHP CHRISTOPHER CASTILLO CUENCA MÉDICO ANATOMOPATÓLOGO C.M.P. 56435 R.N.E. 029091